MÉMORISER • CADRE INFIRMIER

# 4 concepts + 6 écoles

CM0 • La discipline infirmière — Moodle UE A1/S1

## LES 4 CONCEPTS CENTRAUX

| | |
|---|---|
| PERSONNE<br>Être unique et global : physique, psychologique, social, spirituel. | SANTÉ<br>Bien-être physique, mental et social ; pas seulement absence de maladie. |
| ENVIRONNEMENT<br>Facteurs physiques, sociaux, culturels, économiques qui influencent la santé. | SOIN<br>Promouvoir la santé, prévenir, soulager, accompagner. |

## 6 ÉCOLES • UN REPÈRE PAR COURANT

| | |
|---|---|
| Besoins<br>Henderson, Orem : autonomie, besoins, auto-soin. | Interaction<br>Peplau : relation thérapeutique, expérience vécue. |
| Effets souhaités<br>Roy, Gordon : adaptation, équilibre, recueil structuré. | Promotion santé<br>Allen : partenariat, famille, comportements de santé. |
| Être humain unitaire<br>Rogers, Parse : personne-environnement, sens de l’expérience. | Caring<br>Watson, Leininger : prendre soin, valeurs et culture. |

## CONCEPT ≠ THÉORIE ≠ MODÈLE

Concept = idée • Théorie = concepts reliés pour expliquer • Modèle = structure qui oriente observation et action.

## FIL DU RAISONNEMENT

OBSERVER → cadre conceptuel → ANALYSER / DÉCIDER → AGIR → ÉVALUER / TRANSMETTRE

MÉMORISER • BESOINS ET APPLICATION

# Henderson + repères de stage

A5 paysage • recto et verso à la même orientation, marge perforation inversée au verso

## LES 14 BESOINS FONDAMENTAUX

| | |
|---|---|
| 01 Respirer | 02 Boire et manger |
| 03 Éliminer | 04 Se mouvoir / posture |
| 05 Dormir / se reposer | 06 Se vêtir / se dévêtir |
| 07 Maintenir la température | 08 Être propre / protéger les téguments |
| 09 Éviter les dangers | 10 Communiquer |
| 11 Agir selon croyances / valeurs | 12 S’occuper / se réaliser |
| 13 Se récréer | 14 Apprendre |

## EN STAGE • 4 QUESTIONS

| | |
|---|---|
| PERSONNE<br>Que dit-elle ? Que souhaite-t-elle ? Quelles capacités et priorités ? | SANTÉ<br>Quel besoin est perturbé ? Quels signes, risques et ressources ? |
| ENVIRONNEMENT<br>Qu’est-ce qui aide ou freine ? Quelles habitudes, proches, aides ? | SOIN<br>Quel objectif partagé ? Quelle action, surveillance, réévaluation ? |

## CAS EXPRESS • MME X, 78 ANS, CHUTE + FRACTURE, REFUS DE SE LEVER

Ne pas réduire au refus : rechercher douleur, peur, compréhension, risques, ressources et priorités. Écouter, proposer un objectif progressif avec son accord, évaluer et transmettre.

## RÔLE IDE

Observer • écouter • recueillir • analyser • planifier • agir dans son champ • réévaluer • transmettre. Respecter consentement, dignité, choix et culture.